

PARTIE 1 : QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES (QCM)

QCM 1 — Thrombose Veineuse Profonde (TVP)

Parmi les propositions suivantes concernant les signes cliniques locaux de la TVP au stade initial, laquelle est **EXACTE** ?

- A) La douleur diminue à la dorsiflexion du pied.
- B) Le signe de Homans est positif (douleur à la dorsiflexion du pied).
- C) L'œdème du mollet s'accompagne d'une augmentation du ballotement.
- D) La jambe présente une sensation de froid intense et de cyanose d'emblée.

QCM 2 — Embolie Pulmonaire (EP)

Concernant le tableau clinique de l'Embolie Pulmonaire à démarrage brutal, quel signe clinique est lié à une baisse anormale de la quantité d'oxygène dans le sang artériolaires (hypoxémie) ?

- A) La syncope par baisse de la perfusion cérébrale.
- B) La cyanose.
- C) La fièvre entre 38°C et 38,5°C.
- D) L'hémoptysie par nécrose tissulaire.

QCM 3 — Angor d'effort (Angine de poitrine stable)

Quel est le terme utilisé pour qualifier un angor dont la douleur cède 1 à 2 minutes après la prise de Trinitrine (TNT) ?

- A) Angor réfractaire
- B) Angor trinitro-sensible
- C) Angor instable
- D) Angor de repos

QCM 4 — Traitement de l'Embolie Pulmonaire

En cas d'embolie pulmonaire, quel est le débit recommandé pour l'oxygénothérapie par sonde nasale afin de lutter contre l'hypoxie ?

- A) 1 à 2 litres d'O₂ / min
- B) 3 à 4 litres d'O₂ / min
- C) 5 à 6 litres d'O₂ / min
- D) 9 à 10 litres d'O₂ / min

PARTIE 2 : QUESTIONNEMENT À CHOIX DOUBLE (VRAI / FAUX)

Propositions	Vrai	Faux
1. L'utilisation d'HBPM (ex: Lovenox*) nécessite une surveillance systématique du TCA / TCK.		
2. Dans l'angor d'effort, la douleur survient typiquement au repos et dure plus de 30 minutes.		
3. La surélévation des membres inférieurs chez un patient alité atteint de TVP permet de faciliter le retour veineux.		
4. L'hypertension artérielle (HTA) multiplie par 7 les risques de développer de l'athérosclérose.		
5. Le dosage des D-Dimères est un marqueur d'activation de la coagulation utilisé dans le bilan de la TVP.		
6. La position 1/2 assise est préconisée lors de l'accueil d'un patient souffrant d'angor ou d'embolie pulmonaire.		

PARTIE 3 : CAS CLINIQUE PRATIQUE

Situation Clinique : M. Robert, 62 ans

M. Robert, 62 ans, aux antécédents de tabagisme actif et de sédentarité, est admis aux urgences. Il rapporte avoir ressenti une douleur thoracique rétrosternale constrictive (« en étau ») alors qu'il passait le râteau dans son jardin. La douleur a irradié vers sa mâchoire inférieure et son bras gauche, durant environ 2 minutes avant de céder lorsqu'il s'est arrêté de travailler.

Questions :

1. **Identification** : Quel diagnostic évoquez-vous au vu de la clinique et des circonstances d'apparition ?
2. **Facteurs de risque** : Identifiez les facteurs de risque majeurs et mineurs présents ou cités dans le cours pour cette pathologie.
3. **Prise en charge infirmière immédiate** : Citez au moins 4 actions infirmières prioritaires lors de l'accueil de ce patient.
4. **Bilan biologique** : Quels examens biologiques spécifiques (enzymes cardiaques) le médecin va-t-il prescrire pour faire le bilan biologique d'urgence ?

Correction et Éléments de Réponse

Correction Partie 1 : QCM

QCM 1 : B. Le signe de Homans (douleur provoquée à la dorsiflexion du pied) est un signe local évocateur de la TVP. On observe également une baisse du ballotement du mollet.

QCM 2 : B. La cyanose est causée par l'hypoxémie (diminution de l'oxygène dans le sang artériel). La syncope est due à la baisse du débit cardiaque/perfusion cérébrale.

QCM 3 : B. On dit que l'angor est trinitro-sensible lorsque la crise cède 1 à 2 minutes après l'administration de Trinitrine.

QCM 4 : C. Selon le protocole de prise en charge de l'hypoxie dans l'EP, l'oxygénothérapie se fait par sonde nasale à raison de 5 à 6 L/min.

Correction Partie 2 : Vrai / Faux

1. FAUX : Le TCA/TCK surveille l'Héparine Non Fractionnée (HNF / Calciparine). Pour les HBPM (Lovenox*), on surveille l'activité Anti-Xa et le taux de plaquettes (2 fois/semaine).

2. FAUX : L'angor d'effort survient à l'effort, et sa durée est brève (entre 1 et 3 minutes).

3. VRAI : La surélévation des membres inférieurs facilite le retour veineux au lit.

4. VRAI : L'HTA est un facteur de risque majeur qui multiplie par 7 les chances de développer de l'athérosclérose.

5. VRAI : Les D-dimères sont des marqueurs de la fibrinolyse et de l'activation de la coagulation.

6. VRAI : La position ½ assise est recommandée pour optimiser le confort respiratoire et hémodynamique.

Correction Partie 3 : Cas Clinique

1. Diagnostic : Angor d'effort (ou Angor stable).

2. Facteurs de risque :

- Majeurs : Tabagisme actif, Athérosclérose (si présente).
- Mineurs : Sédentarité, âge/sexe.

3. Actions infirmières immédiates :

- Installer le patient en position 1/2 assise.
- Rassurer le patient et lui expliquer les soins.
- Imposer un repos strict au lit.
- Prendre les paramètres vitaux (Pouls, TA, FR, Température).
- Réaliser un ECG en urgence et le transmettre au médecin.
- Oxygénothérapie par sonde ou masque si besoin.
- Poser un cathéter périphérique (SGI) avec rampe IV.

4. Bilan biologique spécifique : Enzymes cardiaques : Troponine (I ou T), CPK / CPK-MB, ASAT, ALAT, LDH.